

SEHA

Clinic Operations & RME Platform — “Kembalikan Waktu Dokter untuk Pasien”

Versi: 1.0 **Tanggal:** 20 Juni 2026 **Basis:** Solo (Surakarta), Jawa Tengah

Status: Internal — perencanaan & penggalangan modal

Seluruh angka pasar, finansial, dan proyeksi bersifat **ilustratif/asumsi** untuk perencanaan. Wajib divalidasi dengan riset pasar & data operasional aktual.

1. Ringkasan Eksekutif

SEHA adalah platform operasional klinik & Rekam Medis Elektronik (RME) berbasis web yang dirancang **sederhana, cepat, dan low-click** untuk praktik mandiri dan klinik kecil di Indonesia. Produk menyasar titik nyeri utama dokter: dokumentasi manual yang tersebar dan EMR yang terlalu rumit.

Dengan diwajibkannya RME (Permenkes 24/2022) dan dorongan interoperabilitas SATUSEHAT, kebutuhan akan sistem yang ringan namun patuh regulasi sangat besar. SEHA menyediakan registrasi & antrean, RME/SOAP, KMS tumbuh kembang anak, farmasi & inventory, kasir, laporan, reminder, dashboard manajemen, dan website publik praktik.

Model bisnis: SaaS langganan tahunan per klinik (±Rp14,4jt/klinik/tahun, all-in). Biaya pengembangan produk diperlakukan sebagai investasi (capital), dipulihkan melalui pertumbuhan basis pelanggan.

Harga langganan / klinik / tahun

Rp14,4 juta

Kontribusi margin / klinik / tahun

Rp5,8 juta

Overhead general / tahun

Rp267,6 juta

Break-even

±47 klinik

Putusan kelayakan: LAYAK (GO) — secara teknis & operasional sangat layak; secara ekonomi layak pada skala ≥47 klinik (tercapai ±tahun ke-2 pada laju akuisisi wajar); fase awal bersifat investasi.

2. Visi, Misi & Produk

Visi: menjadi sistem operasional klinik termudah dan paling patuh regulasi untuk praktik mandiri & klinik kecil di Indonesia.

Misi: mengembalikan waktu dokter untuk pasien dengan mengurangi beban administrasi, sambil menyiapkan klinik untuk era RME & SATUSEHAT.

Modul produk

- Registrasi & antrean (aturan keadilan online/offline)
- RME / SOAP + kode ICD-10 + (simulasi) Ambience AI Scribe
- KMS Digital Anak — kurva pertumbuhan persentil
- Farmasi & inventory + pergerakan stok + monitoring kadaluarsa
- Kasir & billing
- Laporan PDF, surat sehat/sakit, reminder center
- Dashboard manajemen (analitik bulanan)
- Website publik praktik + kesiapan SATUSEHAT/HL7 FHIR (Fase 2)

3. Masalah & Peluang

- **Dokumentasi manual** menyita waktu dokter & rawan tercecer.
- **EMR existing terlalu kompleks** — banyak klik, lambat untuk praktik harian.
- **Regulasi RME diwajibkan** (Permenkes 24/2022) — fasyankes wajib beralih ke rekam medis elektronik.
- **Dorongan SATUSEHAT** — interoperabilitas nasional menjadi kebutuhan.

Peluang: Indonesia memiliki puluhan ribu praktik mandiri & klinik pratama yang belum terdigitalisasi dengan baik — pasar besar untuk solusi RME ringan, terjangkau, dan patuh regulasi.

4. Analisis Pasar

Segmen	Deskripsi	Prioritas
Praktik mandiri dokter	Dokter umum/spesialis praktik sendiri — butuh sistem ringan	Utama
Klinik Pratama	Klinik kecil multi-staf	Utama
Klinik Utama	Lebih kompleks, multi-poli	Sekunder

Lanskap kompetisi & positioning

Vendor EMR existing cenderung kompleks/mahal atau fokus fasyankes besar. **Positioning SEHA:** paling sederhana, low-click, terjangkau, dan ramah praktik anak/pediatric (fitur KMS) — dengan kepatuhan RME & kesiapan SATUSEHAT. Strategi masuk regional (Solo–Yogyakarta) lalu ekspansi.

5. Model Bisnis & Struktur Biaya

Pendapatan

- **Langganan tahunan:** ±Rp14,4 juta/klinik/tahun (all-in: hosting, domain, pemeliharaan, dukungan, update).
- **Onboarding:** ±Rp3 juta sekali (deploy, migrasi, pelatihan).
- **Fase 2 (add-on):** integrasi WhatsApp, SATUSEHAT, billing lanjutan — biaya terpisah.

Pengeluaran General (overhead perusahaan) — basis Solo

Komponen	/bulan	/tahun
Langganan Claude (Team) — US\$200 @ Rp16.500	Rp3.300.000	Rp39.600.000
Gaji CEO (standar Solo)	Rp12.000.000	Rp144.000.000
Gaji Business Development & Product Strategy (Solo)	Rp7.000.000	Rp84.000.000
Total Overhead General	Rp22.300.000	Rp267.600.000

Biaya langsung per klinik (COGS) & unit economics

Item	Nilai/tahun
Harga langganan / klinik	Rp14.400.000
COGS langsung / klinik (infra + pemeliharaan)	Rp8.600.000
Kontribusi margin / klinik	Rp5.800.000

Biaya pengembangan (capital, one-time)

Pengembangan produk: **Rp108.000.000** (diperlakukan sebagai investasi/CapEx, bukan dibebankan ke satu klinik).

6. Proyeksi Keuangan (3 Tahun, ilustratif)

Asumsi: akuisisi rata-rata ±4 klinik/bulan; harga Rp14,4jt; COGS Rp8,6jt/klinik; overhead tumbuh moderat seiring penambahan staf.

Indikator	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
Klinik aktif (akhir tahun)	24	60	120
Klinik rata-rata (basis pendapatan)	13	42	90
Pendapatan langganan	Rp187,2 jt	Rp604,8 jt	Rp1.296 jt
COGS langsung	Rp111,8 jt	Rp361,2 jt	Rp774 jt
Laba kotor (kontribusi)	Rp75,4 jt	Rp243,6 jt	Rp522 jt
Overhead general	Rp267,6 jt	Rp300 jt	Rp360 jt
Laba/(Rugi) bersih — T1	(Rp192,2 jt)	—	—
Laba/(Rugi) bersih — T2	—	(Rp56,4 jt)	—
Laba bersih — T3	—	—	+Rp162 jt

- **Break-even operasional:** ±47–52 klinik → tercapai sekitar pertengahan Tahun 2.
- **Profitabilitas:** mulai Tahun 3.
- **Kebutuhan pendanaan (runway):** ±Rp108jt (build) + akumulasi rugi T1–T2 (±Rp250jt) ≈ **Rp350–400 juta** untuk mencapai profitabilitas.

7. Strategi Go-to-Market

- 1. **Pilot / Founding Partner:** Praktik Mandiri dr. Aisyah Fikritama, S.A. sebagai klien perdana & studi kasus.
- 2. **Ekspansi regional:** Solo–Yogyakarta via referral dokter & komunitas praktik anak.
- 3. **Bukti nilai:** testimoni, efisiensi waktu, kepatuhan RME → memperkuat akuisisi.
- 4. **Kanal:** demo langsung, asosiasi profesi, konten edukasi RME/SATUSEHAT.
- 5. **Retensi:** dukungan responsif + update berkelanjutan + roadmap Fase 2.

8. Organisasi & Tim

Peran	Tanggung jawab	Basis
CEO	Strategi, kemitraan, operasional, penggalangan modal	Solo
Business Development & Product Strategy	Akuisisi klinik, riset kebutuhan, arah produk	Solo
Engineering (project-based)	Pengembangan & pemeliharaan produk	Remote/Proyek

Tim sengaja ramping (lean) dengan biaya basis Solo untuk menjaga overhead rendah dan mempercepat break-even.

9. Studi Kelayakan (Ringkas)

Dimensi	Putusan	Catatan
Teknis	Sangat Layak	Next.js + cloud terjangkau; prototype 17 halaman sudah live
Operasional	Layak	Low-click; onboarding & dukungan ringan
Pasar	Layak	RME diwajibkan; pasar besar & belum tergarap
Ekonomi	Layak Bersyarat	Profit pada skala ≥47 klinik; fase awal = investasi
Hukum	Bersyarat	Wajib hardening PDP/RME sebelum data nyata
Jadwal	Layak	MVP siap; iterasi cepat

10. Analisis Risiko & Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Akuisisi klinik lebih lambat dari proyeksi	Break-even mundur	Pilot kuat, referral, harga kompetitif, fokus regional
Runway/pendanaan kurang	Tinggi	Jaga overhead Solo rendah, milestone pendanaan, pendapatan onboarding
Kepatuhan PDP/RME	Tinggi	Hardening keamanan, audit, kemitraan kepatuhan
Persaingan vendor besar	Sedang	Diferensiasi: simpel, terjangkau, ramah pediatri
Ketergantungan engineering	Sedang	Dokumentasi, kode terstruktur, kontrak pemeliharaan

11. Roadmap

Fase	Fokus
Fase 1 (MVP — selesai)	Operasional inti + RME + KMS + kasir + dashboard + website publik
Fase 1.5 (Hardening)	Autentikasi, database, enkripsi, audit log, kepatuhan PDP/RME
Fase 2 (Automasi)	Integrasi WhatsApp, SATUSEHAT dua arah, billing/asuransi, analitik lanjutan
Fase 3 (Skala)	Multi-cabang, self-service onboarding, ekspansi nasional

12. Kesimpulan

SEHA layak dikembangkan sebagai produk SaaS RME ringan untuk praktik mandiri & klinik kecil. Dengan biaya tim basis Solo yang efisien, **break-even tercapai pada ±47 klinik** dan profitabilitas pada Tahun 3. Pilot dengan dr. Aisyah menjadi fondasi bukti nilai dan pintu masuk ekspansi regional. Kunci keberhasilan: eksekusi akuisisi yang disiplin, kepatuhan regulasi, dan menjaga overhead tetap ramping.